Diagrammi e tabelle - Serie 2

Numero di esercizi: 18 Tempo a disposizione: 45 minuti

1. La Lega contro il cancro ha suddiviso la frequenza (incidenza) e la mortalità di tutti i tipi di cancro per sesso. (Fonte: Lega contro il cancro)

I tipi di cancro più frequenti per sesso (incidenza)

Uomini			Donne	
Cancro della prostata	28%	§	Cancro del seno	32%
Cancro del polmone	12%		Cancro del colon	10%
Cancro del colon	11%		Cancro del polmone	10%
Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	7%		Cancro pigmentato della pelle (melanoma maligno)	7%
Cancro della vescica	4%		Cancro del corpo dell'utero	5%

§ *Chiave di lettura (es.): Il 27.5% di tutti i casi di cancro negli uomini interessa la prostata.*

I tipi di cancro con maggiore mortalità per sesso

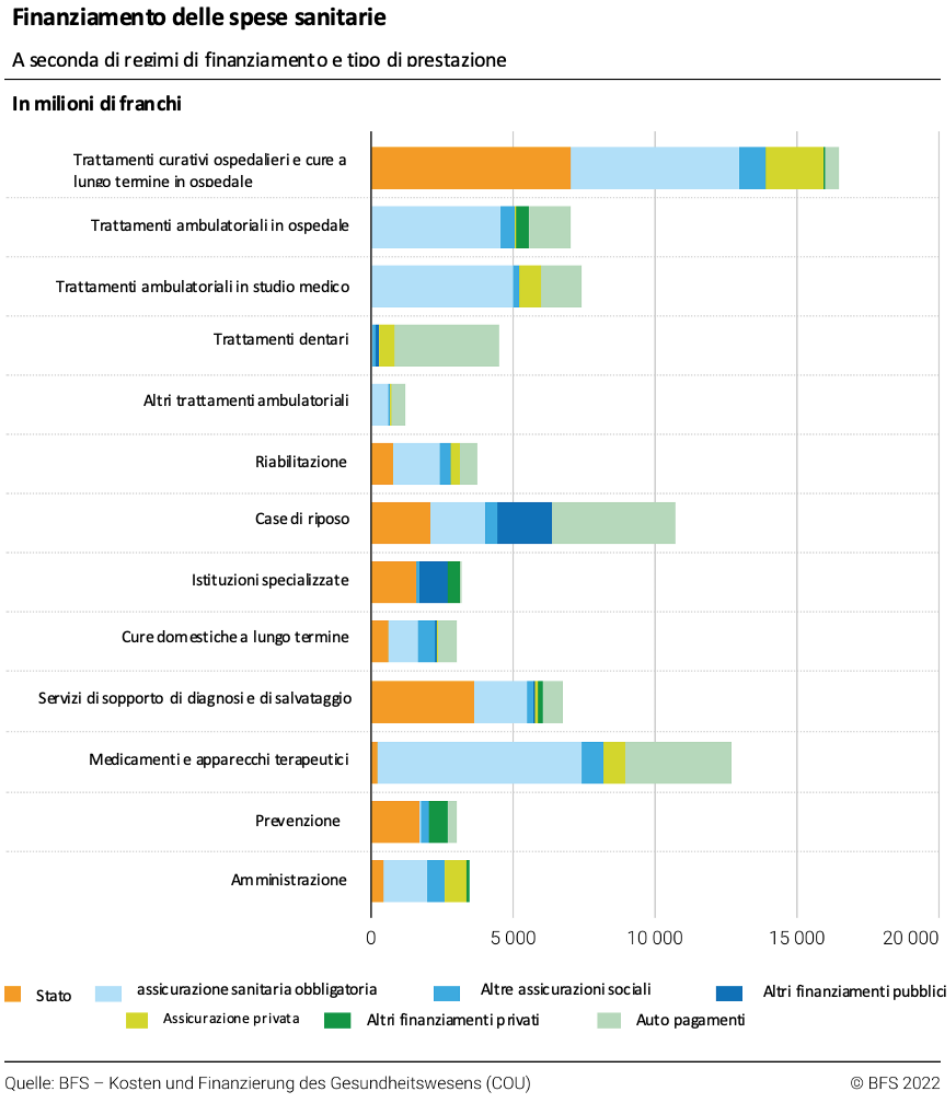
Uomini			Donne	
Cancro del polmone	21.3%	#	Cancro del seno	17.9%
Cancro della prostata	14.3%		Cancro del polmone	16.2%
Cancro del colon	9.8%		Cancro del colon	9.8%
Cancro del pancreas	6.8%		Cancro del pancreas	8.7%
Cancro del fegato	5.4%		Cancro dell'ovaio	5.5%

Chiave di lettura (es.): Il cancro del polmone è responsabile del 21.3% di tutti i decessi per cancro negli uomini.

Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre dall'illustrazione?

(A) Il sistema riproduttivo è più spesso colpito dal cancro a causa dell'aumento del metabolismo cellulare.
(B) Dopo il cancro al seno o alla prostata, la maggior parte delle persone muore di cancro al colon.
(C) Circa il 40% di tutti i tumori maschili colpiscono i polmoni o la prostata.
(D) Il cancro alla vescica non si manifesta nelle donne.
(E) A parità di numero di donne e uomini, circa il 10% della popolazione muore di cancro al colon.

2. Il seguente diagramma mostra come sono state finanziate le diverse categorie di spese sanitarie in Svizzera nel 2020.



Quale o quali delle seguenti affermazioni si possono dedurre dall'illustrazione?

I. Il sostegno statale rappresenta una quota maggiore dei trattamenti curativi ospedalieri rispetto a tutte le altre categorie.

II. I trattamenti dentari, in particolare, sono relativamente i più pagati dal paziente.

III. Nel 2020, sono stati effettuati oltre 5'000 trattamenti ambulatoriali negli studi medici.

(A) Tutte le affermazioni sono corrette.

(B) Solo l'affermazione III è corretta.

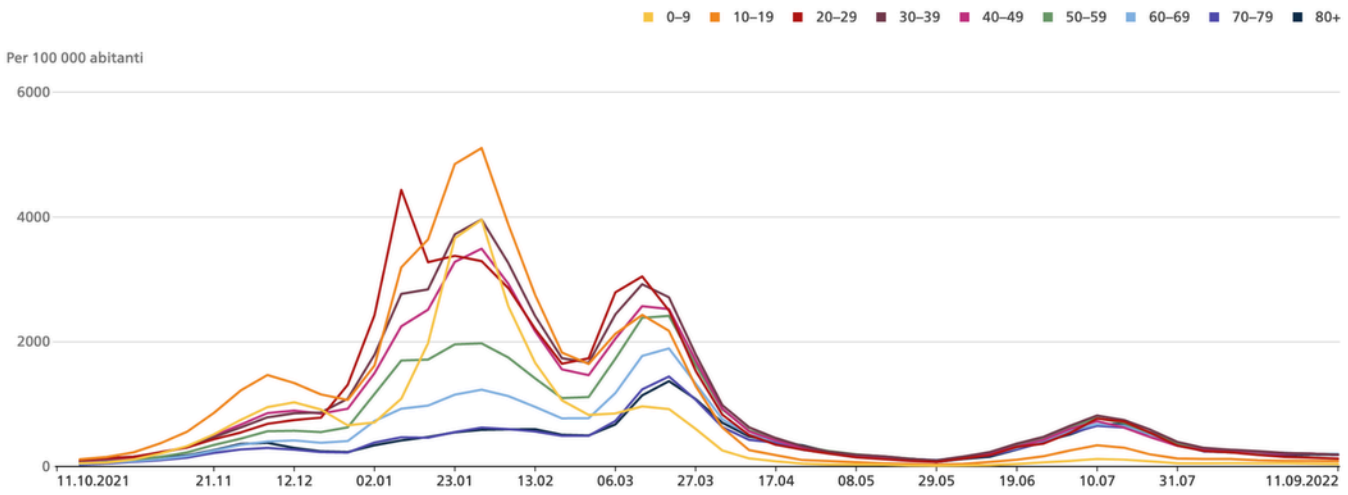
(C) Solo l'affermazione II è corretta.

(D) Le affermazioni II e III sono corrette.

(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

3. Il virus "Sars-CoV-2" è l'agente infettivo che causa la malattia infettiva Covid-19. Questo virus è responsabile della pandemia globale di Coronavirus in corso dalla primavera del 2020.

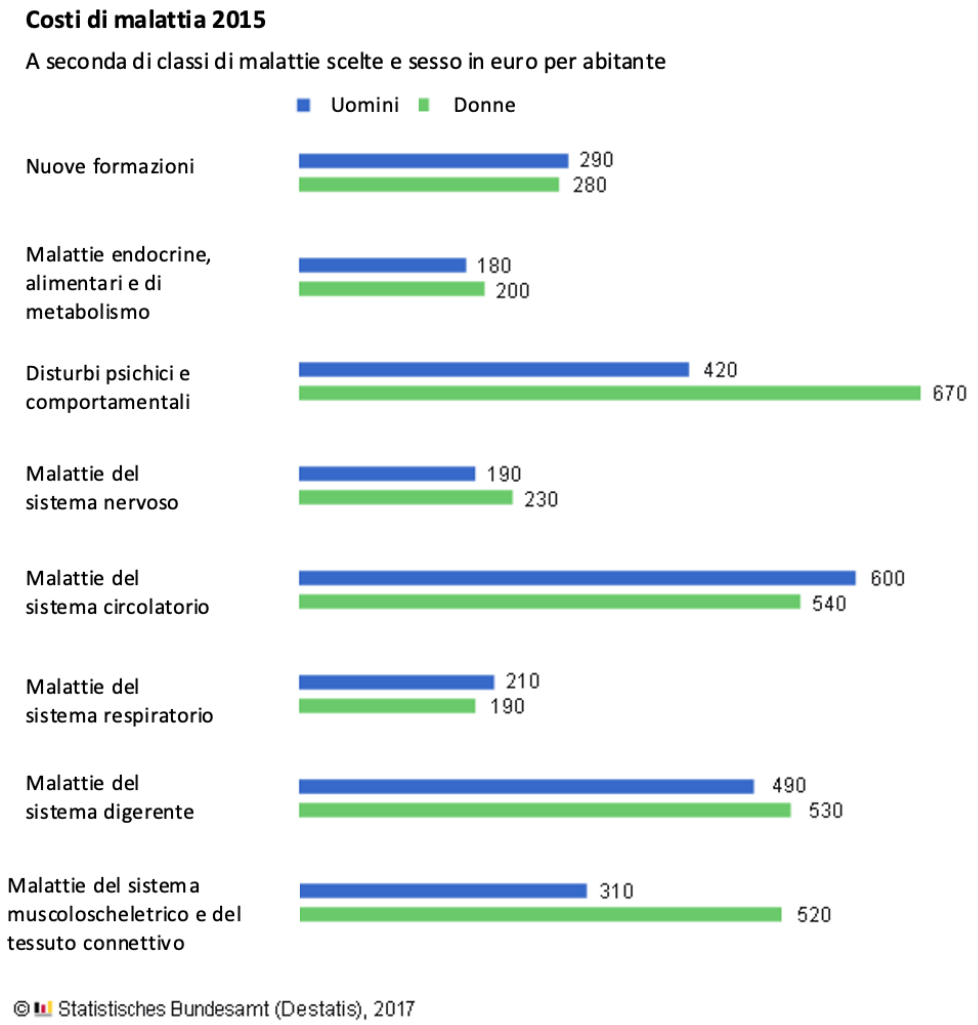
Il seguente grafico mostra i casi di infezione da Sars-CoV-2 confermati in laboratorio in Svizzera e nel Liechtenstein nel periodo compreso tra l'11.10.2021 e il 10.04.2022 suddivisi in diverse fasce di età.



Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal diagramma soprastante?

(A) In Svizzera e nel Liechtenstein non sono state segnalate più di 6'000 infezioni da Sars-CoV-2 in qualsiasi momento durante il periodo citato.
(B) Il 30 gennaio 2022, il numero più alto di infezioni da Sars-CoV-2 dell'intera pandemia di Coronavirus è stato segnalato nella fascia di età compresa tra i 10 e i 19 anni.
(C) Nel gruppo di età 0-9 anni, non sono mai state segnalate più infezioni da Sars-CoV-2 per 100'000 abitanti rispetto al gruppo di età 10-19 anni.
(D) Nel gruppo di età 50-59 anni, il numero di casi segnalati non ha mai superato i 2'000 per 100'000 abitanti.
(E) Tra l'11.10.2021 e il 02.01.2022, non ci sono state più di 2'000 infezioni da Sars-CoV-2 per 100'000 abitanti in qualsiasi gruppo di età.

4. Nel 2017, l'Ufficio federale di statistica tedesco ha pubblicato i costi di malattia della popolazione tedesca per l'anno 2015. Questi sono stati suddivisi tra le varie classi di malattia e ulteriormente separati per sesso.



Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre dall'illustrazione?

(A) I disturbi psichici e comportamentali sono diagnosticati più frequentemente nelle donne.

(B) Il trattamento delle malattie cardiovascolari negli uomini è il più costoso in assoluto.

(C) Le malattie croniche come l'insufficienza cardiaca causano i costi maggiori.

(D) Le malattie endocrine, alimentari e di metabolismo hanno causato i costi minori nel sistema sanitario tedesco nel 2015.

(E) In media, le donne causano più costi di malattia perché vivono più a lungo.

.

5. Il seguente grafico mostra il consumo annuale pro capite di bevande alcoliche in Svizzera tra il 1990 e il 2010.

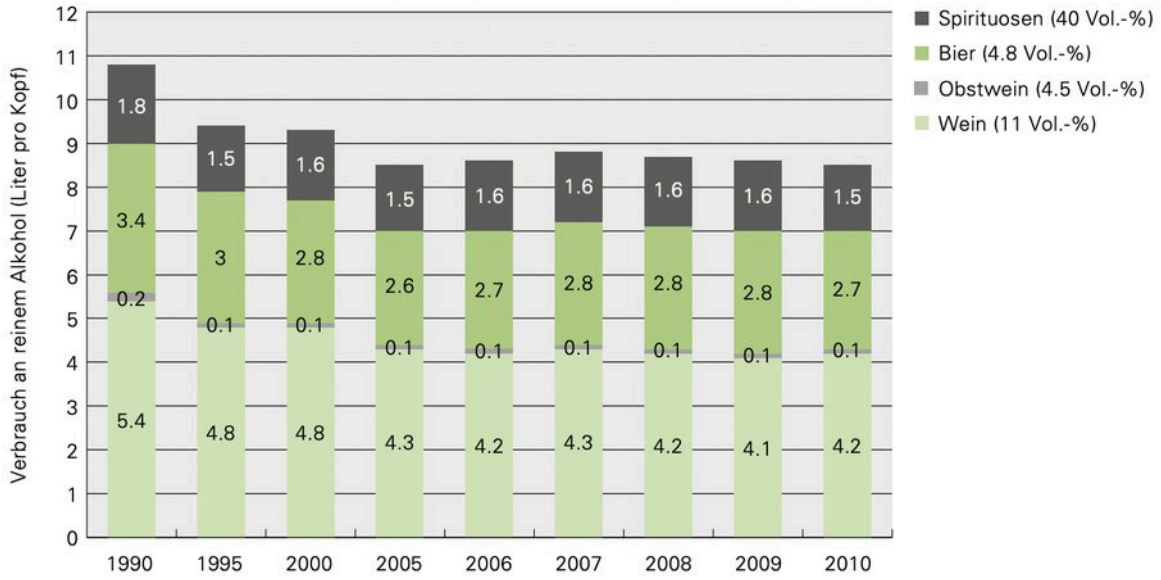


Abbildung 2.4: Jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch alkoholischer Getränke in der Schweiz zwischen 1990 und 2010 (Liter reiner Alkohol; 27)

Quale o quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dall'illustrazione?

I. Il consumo totale di alcol pro capite è diminuito, passando da quasi 11 litri nel 1990 a circa 3,2 litri di meno nel 2010.

II. Il consumo di vino da frutta (Obstwein) è di massimo 0,2 litri all'anno.

III. Il consumo pro capite di alcol è aumentato nel 2009 rispetto al 2008.

(A) Tutte le affermazioni sono vere.

(B) Solo l'affermazione III è vera.

(C) Solo l'affermazione II è vera.

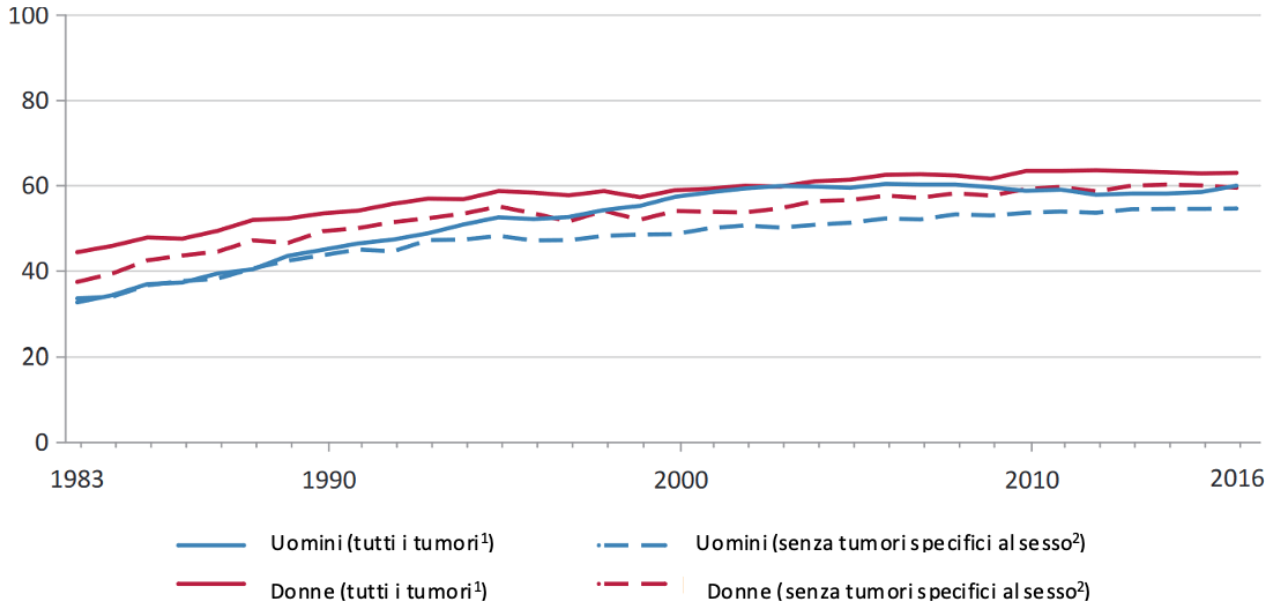
(D) Solo le affermazioni II e III sono vere.

(E) Nessuna delle affermazioni è vera.

6. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni viene utilizzato in epidemiologia per fare affermazioni sulla prognosi dopo una diagnosi di malattia, in particolare dopo una diagnosi di cancro. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni, solitamente espresso in percentuale, indica quanti pazienti sono ancora vivi a 5 anni dalla diagnosi della malattia.

Questo grafico mostra la sopravvivenza relativa a cinque anni dopo una diagnosi di cancro in Austria tra il 1983 e il 2016. I dati provengono dal registro dei tumori austriaco.

Tasso di sopravvivenza per cinque anni relativo dopo una diagnosi di cancro, 1983 a 2016

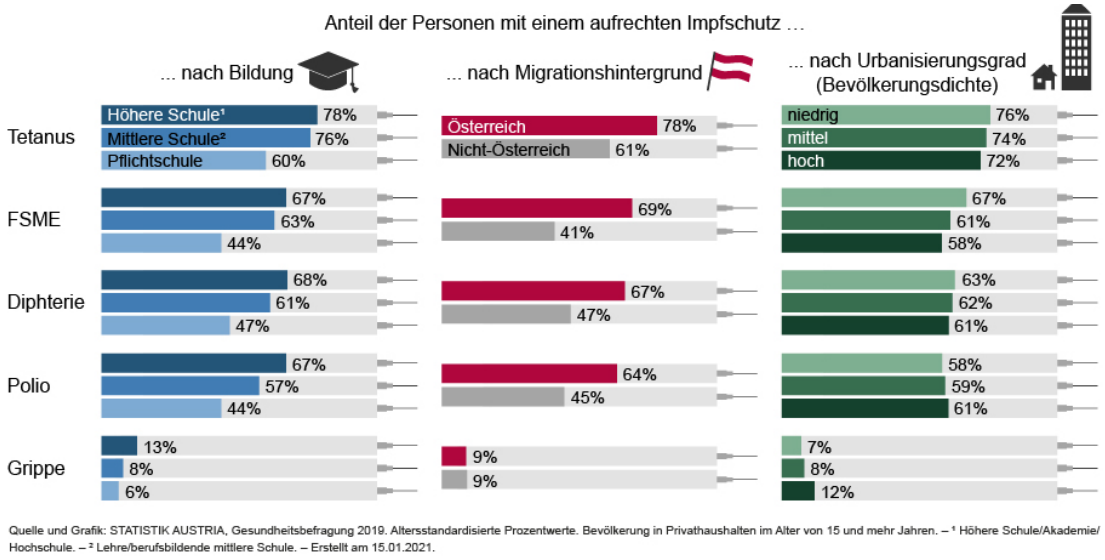


Q: STATISTIK AUSTRIA, Registro tumori austriaco (19.01.2022) e statistiche sulle cause di morte. - Fine del follow-up 31.12.2020. - 1) Casi invasivi maligni senza altre neoplasie maligne della pelle (C00-C96, senza C44) e senza casi di DCO. - 2) Casi maligni invasivi, esclusi il cancro della mammella, il cancro degli organi genitali femminili e maschili (C50, C51-C58, C60-C63), escluse le altre neoplasie maligne della pelle (C44) ed esclusi i casi di DCO.

Quale delle seguenti affermazioni non può essere ricavata dal grafico?

(A) La sopravvivenza relativa a cinque anni negli uomini austriaci è aumentata del 25% nel periodo osservato, raggiungendo il 60% nel 2016, mentre era ancora pari a circa il 35% nel 1983.
(B) Sulla base di questo diagramma non si possono fare affermazioni sullo sviluppo di "altre neoplasie maligne della pelle".
(C) Nel 2003, le donne e gli uomini austriaci a cui era stato diagnosticato un tumore avevano la stessa probabilità di essere ancora vivi nel 2008.
(D) Le donne austriache a cui è stato diagnosticato un tumore non specifico al sesso nel 1995 o nel 2013 hanno avuto maggiori probabilità di essere ancora vive dopo 5 anni rispetto agli uomini che hanno ricevuto una diagnosi di tumore nei rispettivi anni.
(E) Dal 1989, gli uomini austriaci con una diagnosi di cancro hanno avuto una sopravvivenza a cinque anni più alta in termini percentuali rispetto agli uomini con una diagnosi di cancro senza tumori specifici al sesso.

7. Il seguente diagramma illustra il numero di persone vaccinate in Austria. I dati sono stati ordinati in base all'istruzione (in blu), al background migratorio (in rosa) e alla densità di popolazione del luogo di residenza (in verde), nonché alle rispettive vaccinazioni.



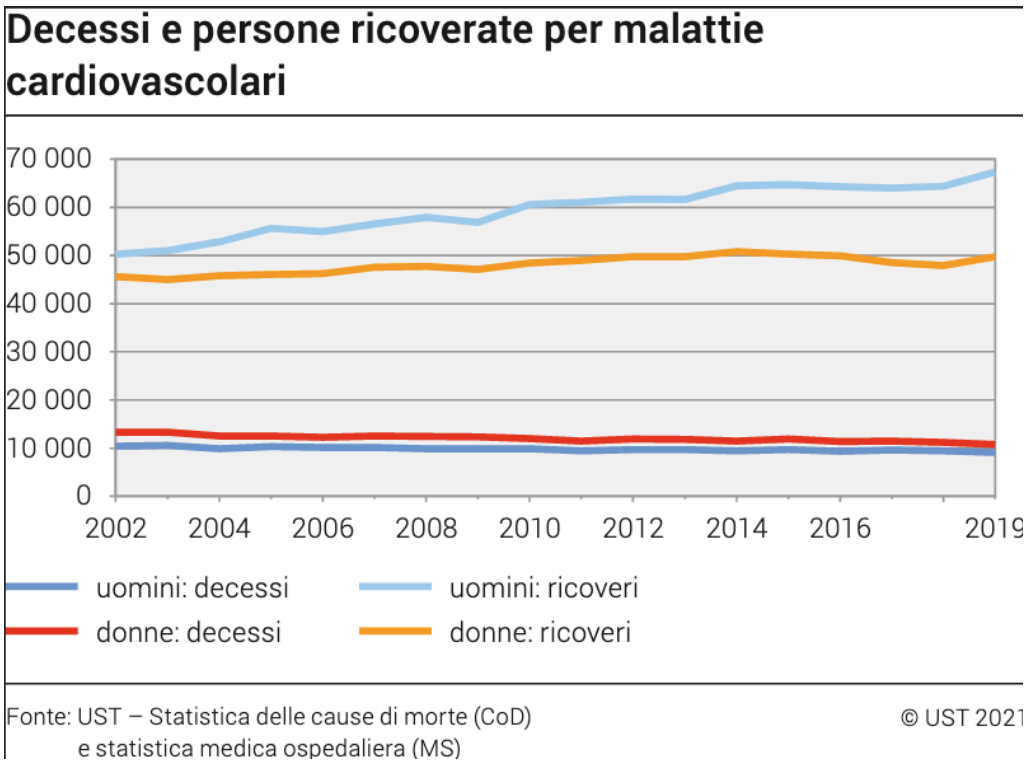
Quelle und Grafik: STATISTIK AUSTRIA, Gesundheitsbefragung 2019. Altersstandardisierte Prozentwerte. Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 und mehr Jahren. – ¹ Höhere Schule/Akademie/Hochschule. – ² Lehre/berufsbildende mittlere Schule. – Erstellt am 15.01.2021.

Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dal diagramma?

(A) Le persone con background migratorio sono meno vaccinate contro il tetano (Tetanus) rispetto a quelle senza background migratorio.
(B) Le persone con un'istruzione superiore si vaccinano più spesso perché sono più informate in merito.
(C) Ad eccezione della poliomielite (Polio), le persone che vivono in regioni densamente popolate (hoch) sono meno vaccinate in termini percentuali.
(D) Lo stesso numero di persone con un'istruzione superiore (höhere Schule) si vaccina contro FSME rispetto alle persone che vivono in regioni a bassa densità (niedrig) di popolazione.
(E) Il numero di persone vaccinate contro il tetano (Tetanus) è relativamente più alto in tutte le aree.

8. Le malattie del sistema cardiovascolare, come l'ipertensione, l'infarto o l'endocardite, sono tra i motivi più comuni di ricovero o morte dei pazienti.

Il seguente grafico mostra il numero di ricoveri e di decessi per malattie cardiovascolari nelle donne e negli uomini tra il 2002 e il 2019.



I. Fino ad oggi, il numero di uomini ricoverati è aumentato costantemente.

II. Nel periodo osservato, più di 60’000 uomini sono morti a causa di malattie cardiovascolari per la prima volta nel 2010.

III. Tra il 2002 e il 2019, in nessun anno sono state ricoverate più donne che uomini.

IV. Nel 2019, circa 50’000 donne sono state ricoverate in ospedale a causa di un attacco cardiaco.

Quale o quali delle affermazioni possono essere dedotte dal grafico?

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) È possibile dedurre solo l'affermazione III.
(C) Si possono dedurre le affermazioni I e III.
(D) È possibile dedurre le affermazioni I, III e IV.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

9. Il diagramma sottostante illustra l'aspettativa di vita specifica per età degli uomini residenti nel Canton Turgovia. Sono indicati quanti anni le singole fasce di età possono aspettarsi di vivere in media dal 1989/1990 al 2019/2020.

Speranza di vita per età
Canton Turgovia, 1989/1990–2019/2020, speranza di vita in anni

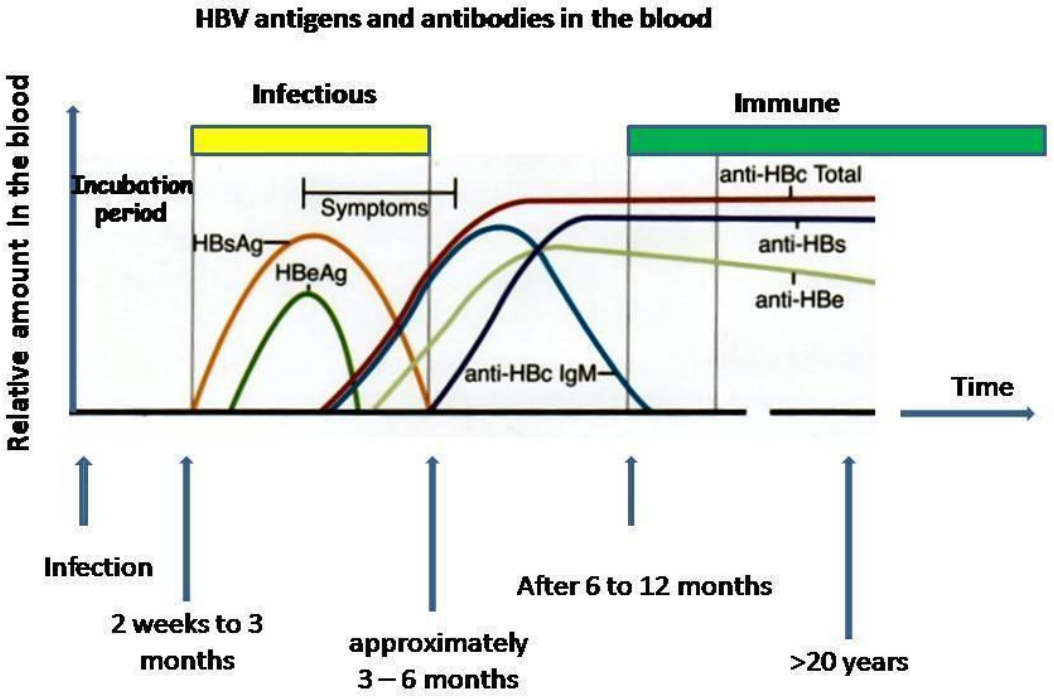
	Uomini				
		All'età di…			
	Alla nascita	15 anni	45 anni	65 anni	80 anni
1989/1990	74.5	60.2	32.4	15.4	7.0
1999/2000	76.9	62.5	33.9	16.6	7.1
2009/2010	80.1	65.3	36.5	18.8	8.4
2014/2015	80.4	66.1	37.2	19.4	8.5
2015/2016	81.4	66.8	37.7	19.8	8.7
2016/2017	81.5	66.9	37.8	19.8	8.6
2017/2018	81.4	66.8	37.6	19.7	8.8
2018/2019	81.7	66.9	37.8	19.9	8.9
2019/2020	81.1	66.7	37.6	19.6	8.6

Quale delle seguenti affermazioni non è deducibile dal diagramma?

(A) Gli uomini di 80 anni hanno un'aspettativa di vita più alta nel 2019/2020 rispetto ai neonati maschi di questi anni.
(B) L'aspettativa di vita in Turgovia nel 2019/2020 per i 45enni è di 82,6 anni.
(C) Dal 1989/1990 al 2018/2019, l'aspettativa di vita dei maschi è aumentata a ogni intervallo di 2 anni.
(D) In questo intervallo di 30 anni, dal 1989/1990 al 2019/2020, l'aspettativa di vita degli uomini alla nascita è aumentata di oltre 5 anni.
(E) Da questa tabella non si possono trarre conclusioni sull'aspettativa di vita degli uomini in Svizzera nel suo complesso.

10. L'epatite B è una forma di epatite virale causata dal virus dell'epatite B (HBV). L'HBV è costituito da diversi antigeni (Ag): gli "antigeni di superficie" (HBsAg), gli "antigeni core" (HBcAg) e gli "antigeni e del virus" (HBeAg). In caso di infezione da HBV, l'organismo forma anticorpi contro questi antigeni attraverso la risposta immunitaria dopo il periodo di incubazione: anti-HBs, anti-HBc e anti-HBe. Nel caso dell'anti-HBc, si distingue anche tra anti-HBc IgM e anti-HBc totale.

Questo diagramma mostra schematicamente le quantità relative di antigeni e anticorpi dell'HBV nel sangue dopo l'infezione con il virus dell'epatite B nel corso del tempo.



I. Il tempo di presenza degli “antigeni e del virus” nel sangue è pari al periodo di incubazione.

II. Nella seconda metà del periodo infettivo di solito compaiono i sintomi, si formano gli anticorpi e gli antigeni diminuiscono.

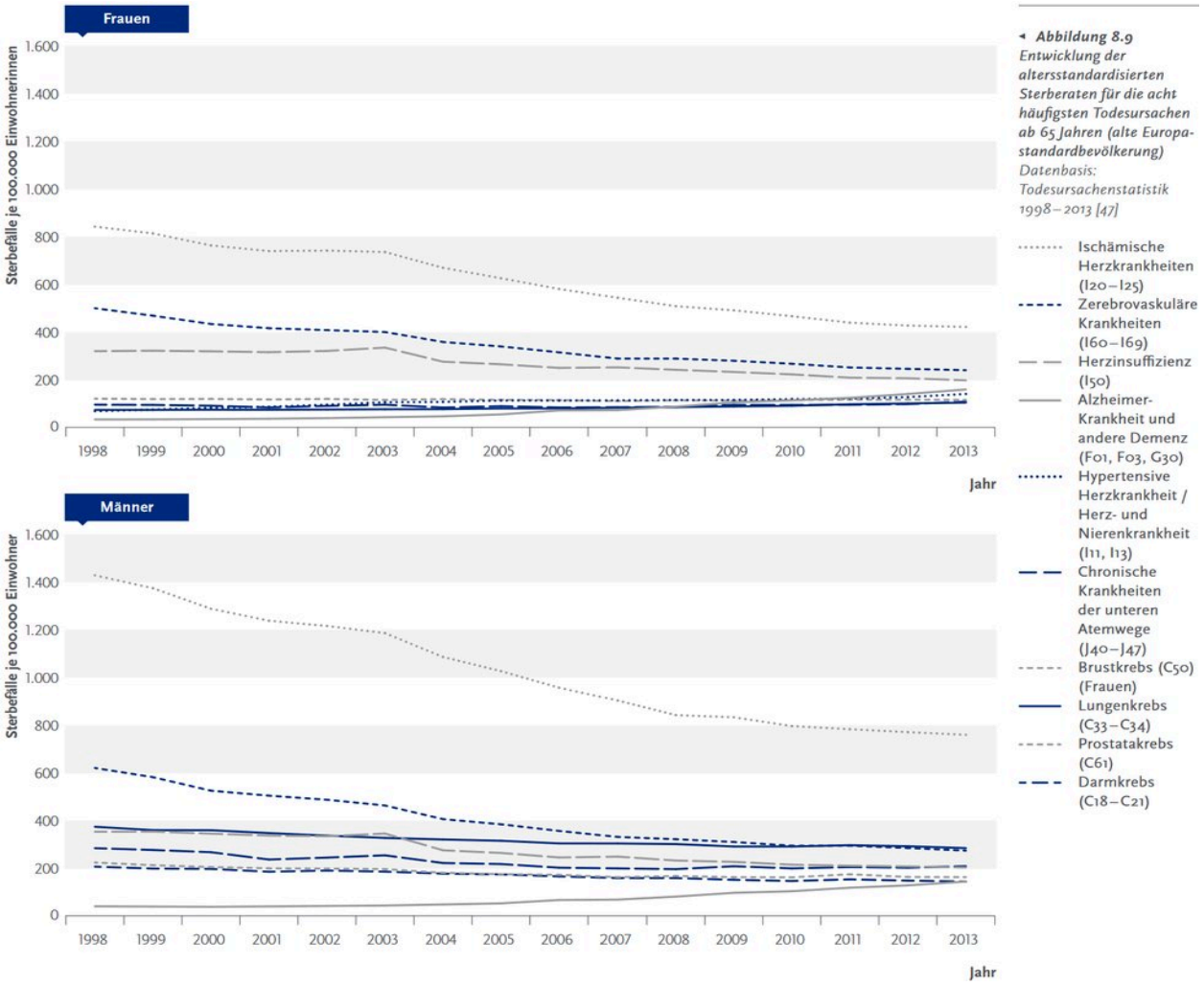
III. Gli “antigeni core” scompaiono solo dopo 6-12 mesi, mentre gli “antigeni di superficie” e gli “antigeni e del virus" scompaiono già dopo 3-6 mesi.

IV. Gli anticorpi contro l'antigene con la quantità relativa più alta si formano per ultimi.

Quale o quali affermazioni si possono dedurre?

(A) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(B) È possibile dedurre solo le affermazioni II e III.
(C) È possibile dedurre solo le affermazioni II e IV.
(D) È possibile dedurre solo le affermazioni II, III e IV.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

11. I seguenti grafici illustrano l'evoluzione nel tempo delle otto cause di morte più frequenti per donne (grafico in alto) e uomini (grafico in basso) di 65 anni e oltre in Germania tra il 1998 e il 2013.



I. Nel 1998, in Germania sono morti più uomini di cancro alla prostata (Prostatakrebs C61) che donne di cancro al seno (Brustkrebs C50).

II. Dal 1998 al 2013, i decessi per cardiopatia ischemica (ischämische Herzkrankheiten) negli uomini di età superiore ai 65 anni sono diminuiti di oltre 600 decessi per 100’000 abitanti, grazie al miglioramento dei metodi diagnostici e a una più ampia gamma di opzioni terapeutiche.

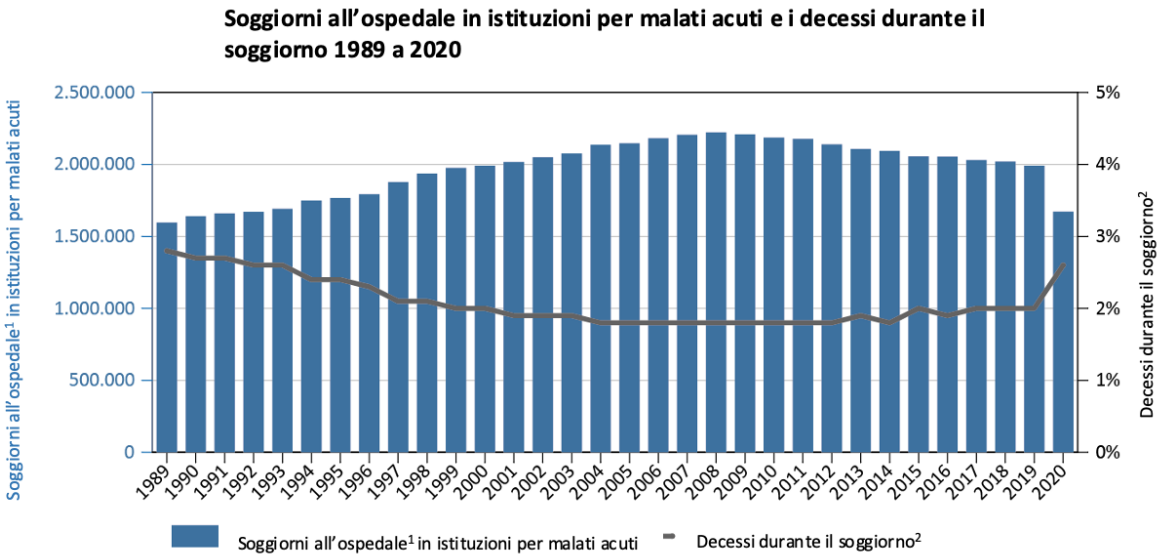
III. La malattia di Alzheimer e altre demenze (Alzheimer-Krankheit und andere Demenz) è una delle otto principali cause di morte che è aumentata maggiormente in termini percentuali tra il 1998 e il 2013 in termini di decessi per 100’000 abitanti.

IV. I decessi per 100’000 abitanti dovuti a insufficienza cardiaca (Herzinsuffizienz) hanno raggiunto un picco per entrambi i sessi a metà del 2003.

Quale o quali affermazioni si possono dedurre dal diagramma?

(A) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.
(B) Si possono dedurre solo le affermazioni I, II e III.
(C) È possibile dedurre solo le affermazioni I, III e IV.
(D) È possibile dedurre solo l'affermazione III.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

12. Nel grafico sottostante, il numero di soggiorni ospedalieri è confrontato con il tasso di mortalità negli ospedali.



Q: STATISTIK AUSTRIA, statistiche sulle dimissioni ospedaliere basate sui dati del Ministero federale degli Affari sociali, della Salute, dell'Assistenza e della Protezione dei consumatori.
Preparato il 29.11.2021. - Riferimento alle dimissioni ospedaliere di persone residenti all'interno e all'esterno dell'Austria; inclusi i decessi.
1) Ricoveri completi (con almeno un pernottamento in ospedale). - 2) Quota di dimissioni ospedaliere con il tipo di dimissione "deceduto" su tutte le dimissioni ospedaliere.

Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta?

(A) Il tasso di mortalità non è direttamente proporzionale al numero di ricoveri ospedalieri.

(B) Nel 1989, è deceduto il maggior numero di persone in ospedale.

(C) Dal 1989 al 2008 si è registrato un aumento costante dei ricoveri ospedalieri.

(D) Nel periodo descritto, non ci sono mai stati più ricoveri ospedalieri rispetto al 2008.

(E) Nel 2020, il numero di decessi in ospedale in rapporto al numero di ricoveri è stato superiore a quello dell'anno precedente.

13. Ogni anno vengono effettuate più di 40’000 nuove diagnosi di cancro. Più di una persona su cinque sviluppa un cancro prima dei 70 anni. Questo fa del cancro una delle cause di morte più comuni in Svizzera.

La tabella che segue mostra la media annuale dei nuovi tumori diagnosticati e dei decessi per il periodo dal 2014 al 2018 per uomini e donne in Svizzera.

Media annuale (per il periodo 2014–2018)	Uomini		Donne	
	Nuovi casi	Decessi	Nuovi casi	Decessi
Tutti i tumori	23 653	9 461	19 969	7 715
Polmoni, bronchi, trachea	2 758	2 005	1 894	1 260
Seno			6 314	1 385
Prostata	6 649	1 352		
Colon e retto	2 529	933	1 978	751
Melanoma della pelle	1 614	183	1 389	127
Tumori infantili[1] (tutti i tipi)	124	11	100	13

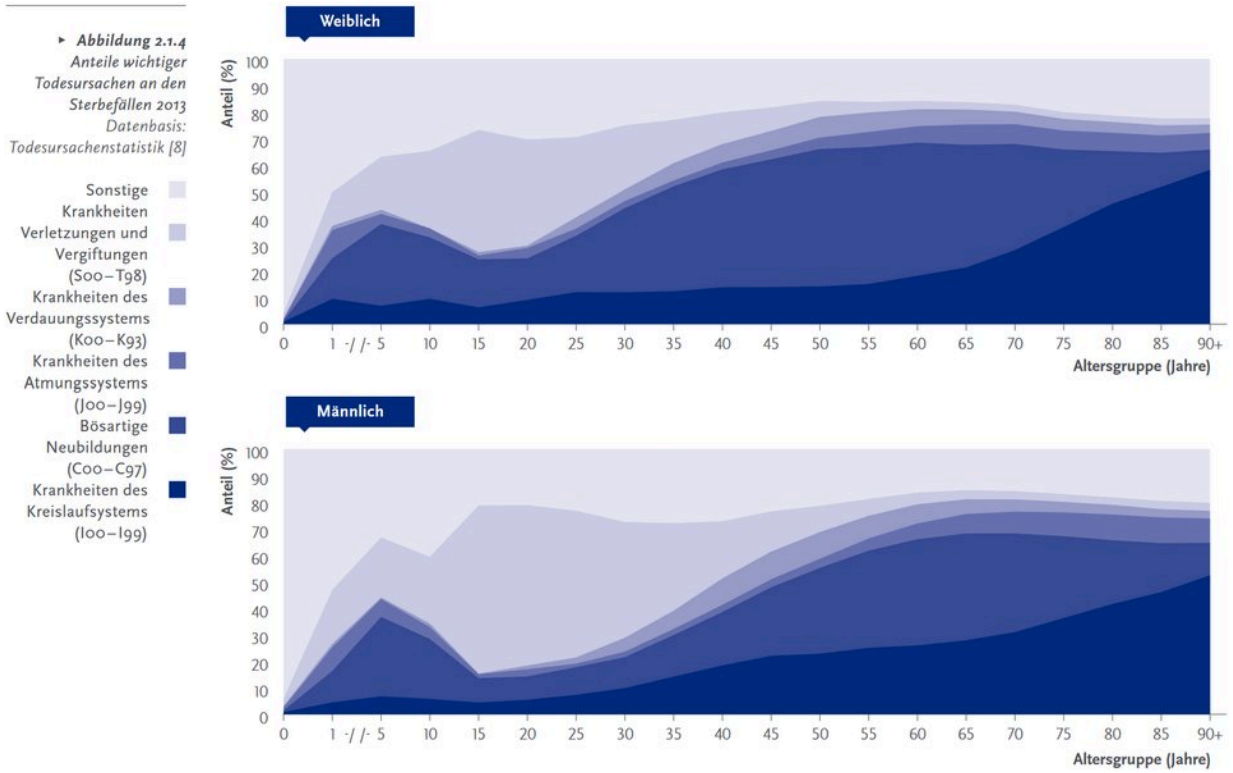
[1] 0–14 anni

Fonte: UST, SNRT, RdTP – Statistica nazionale sui tumori © UST 2022

Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dalla tabella?

(A) Oltre al cancro ai polmoni, al seno, alla prostata, al colon, ai melanomi della pelle e ai tumori infantili, tra il 2014 e il 2018 non si sono registrati nuovi casi di altri tipi di cancro in Svizzera.
(B) Tra il 2014 e il 2018 sono stati diagnosticati in totale 4’507 nuovi casi di cancro colorettale.
(C) Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018, ogni anno sono stati diagnosticati tutti i tipi di cancro a una media di 100 donne sotto i 18 anni.
(D) In media, tra il 2014 e il 2018 in Svizzera è stato diagnosticato un tumore a un numero di uomini tre volte superiore a quello delle donne decedute per tumore nello stesso periodo.
(E) Il numero di nuovi tumori diagnosticati in Svizzera tra il 2014 e il 2018 è rimasto costante sia per gli uomini sia per le donne.

14. I due grafici di questo esercizio mostrano le quote delle principali cause di morte nei decessi in Germania nel 2013 per donne (grafico soprastante) e uomini (grafico sottostante) in base alle diverse fasce d'età.



I. Tra le persone di età superiore ai 90 anni decedute in Germania nel 2013, le malattie del sistema circolatorio (Krankheiten des Kreislaufsystems) hanno rappresentato almeno il 50% di tutte le cause di morte in entrambi i sessi.

II. A parte le malattie del sistema circolatorio (Krankheiten des Kreislaufsystems), non c'è un'altra causa di morte per la quale la percentuale di decessi tra le donne di età compresa tra i 70 e i 75 anni in Germania sia aumentata.

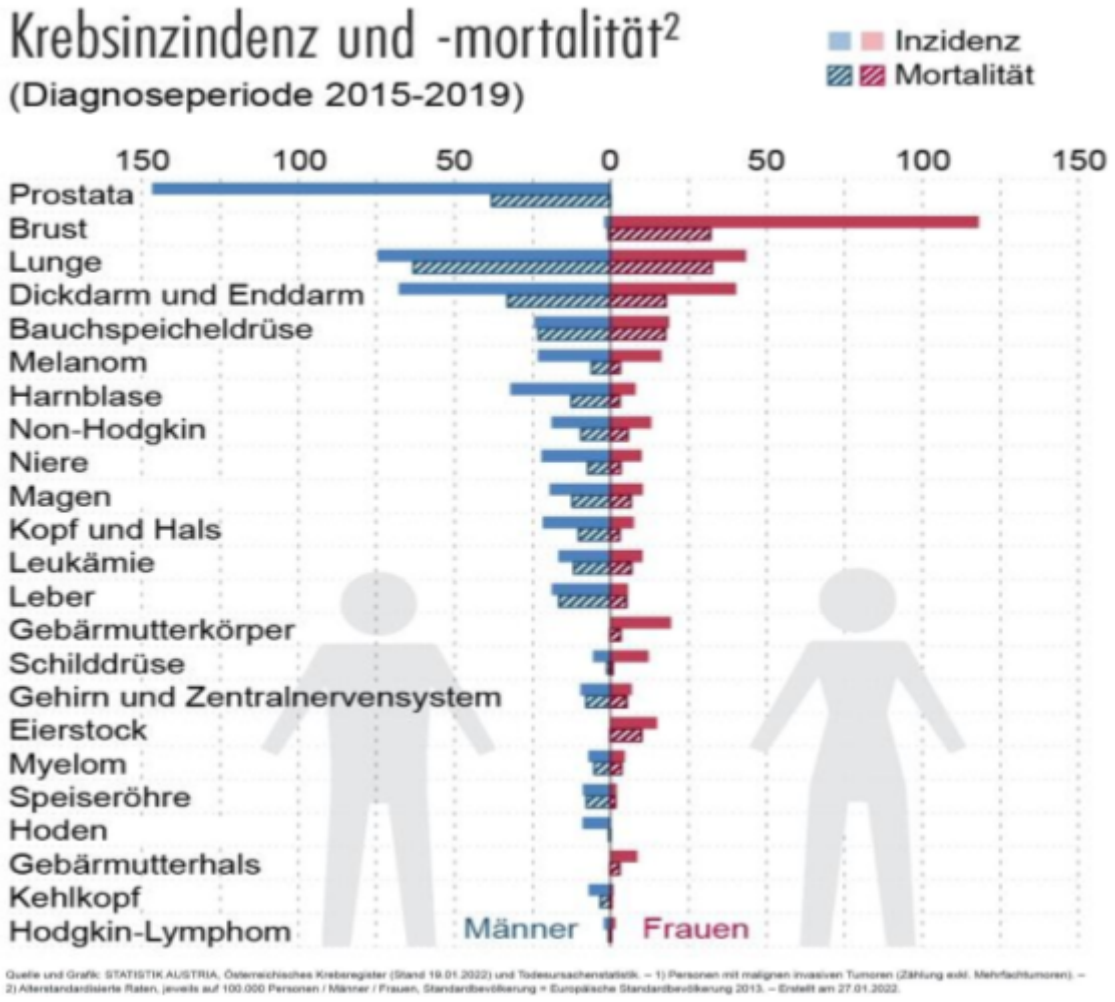
III. Le lesioni e gli avvelenamenti (Verletzungen und Vergiftungen) hanno avuto la loro massima percentuale di decessi nel 2013 in Svizzera tra i quindicenni di entrambi i sessi, con circa il 45% tra i deceduti di sesso femminile e circa il 65% tra i deceduti di sesso maschile.

IV. Nel 2013, in Germania, i cinquantenni sono morti per lesioni e avvelenamenti (Verletzungen und Vergiftungen) con la stessa frequenza delle malattie dell'apparato digerente (Krankheiten des Verdauungssystems).

Quale o quali affermazione sono vere in base ai due grafici dati?

(A) Tutte le affermazioni sono vere.
(B) Solo le affermazioni I, III e IV sono vere.
(C) Solo le affermazioni I e III sono vere.
(D) Solo le affermazioni I e IV sono vere.
(E) Solo l'affermazione IV è vera.

15. Il seguente diagramma mostra la correlazione tra l'incidenza (Inzidenz) (numero di nuovi casi di cancro nella popolazione definita) di vari tipi di cancro per 100’000 persone in Austria e la rispettiva mortalità (Mortalität) (quanti decessi ci sono in confronto a causa del tipo di cancro). La letalità di un tipo di tumore è il valore che descrive la frequenza con cui il tumore porta alla morte e può essere ricavato dalla relazione tra incidenza e mortalità. In blu (a sinistra) i dati per gli uomini, in rosso (a destra) i dati delle donne.



Quale delle seguenti affermazioni <u>non</u> può essere ricavata dal diagramma?

(A) Gli uomini muoiono più spesso di cancro al fegato (Leber) rispetto alle donne.
(B) Il cancro al polmone (Lunge) è uno dei tumori più letali sia per gli uomini che per le donne.
(C) In questa figura sono presenti 3 tumori diagnosticati solo nelle donne.
(D) Il cancro all'esofago (Speiseröhre) è uno dei tumori più letali.
(E) Il tumore della vescica urinaria (Harnblase) è meno comune nelle donne che negli uomini.

16. La tabella mostra la prevalenza (Prävalenz) e l'incidenza (Inzidenz) del diabete di tipo 1 (Typ-1-Diabetes) e di tipo 2 (Typ-2-Diabetes) nei bambini e negli adolescenti (Alter) in Germania, suddivisa per i singoli stati federati (Land) e per la Germania nel suo complesso (Gesamt) e per i singoli periodi di tempo (Zeitraum).

▸ *Tabelle 2.5.1 Prävalenz und Inzidenz des Typ-1- und Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland Datenbasis: KiGGS 2003–2006 [35], KiGGS Welle 1 2009–2012 (eigene Berechnungen) und regionale Registerdaten und Studien [33, 36–40]*

DIABETES-TYP	LAND	ZEITRAUM	ALTER (JAHRE)	PRÄVALENZ (JE 100.000 PERSONEN)	INZIDENZ (JE 100.000 PERSONENJAHRE)	QUELLE
Typ-1-Diabetes	Nordrhein-Westfalen	2007	0 – 19	184		[33]
			0 – 4	34		
			5 – 9	140		
			10 – 14	248		
			15 – 19	278		
		1996 – 2007	0 – 14		20,4	[36]
			0 – 4		14,8	
			5 – 9		22,9	
			10 – 14		23,6	
	Baden-Württemberg	2000 – 2006	0 – 14		19,4	[37]
	Bremen	1999 – 2007	0 – 17		19,2	[38]
	Sachsen	1999 – 2008	0 – 14		17,5	[39]
Typ-2-Diabetes	Baden-Württemberg	2004/2005	0 – 20	2,3		[34]
			0 – 14	0,8		
			15 – 20	5,0		
	Nordrhein-Westfalen	2002 – 2010	5 – 19		1,1	[40]
Gesamt	Deutschland	2003 – 2006	0 – 17	140		[35]
	Deutschland	2009 – 2012	7 – 17	210		KiGGS Welle 1, 2009 – 2012 (eigene Berechnungen)

I. Tra il 2009 e il 2012, la prevalenza del diabete nei bambini di età compresa tra 7 e 17 anni è stata superiore del 50% rispetto alla prevalenza del diabete nei bambini di età compresa tra 0 e 17 anni nel periodo 2003-2006.

II. Tra il 1996 e il 2007, i bambini di età compresa tra i 10 e i 14 anni della Renania Settentrionale-Vestfalia (Nordrhein-Westfalen) hanno avuto le maggiori probabilità di sviluppare il diabete di tipo 1.

III. Rispetto al Baden-Württemberg e alla Renania Settentrionale-Vestfalia, la Sassonia (Sachsen) ha il minor numero di bambini di età compresa tra 0 e 14 anni affetti da diabete di tipo 1.

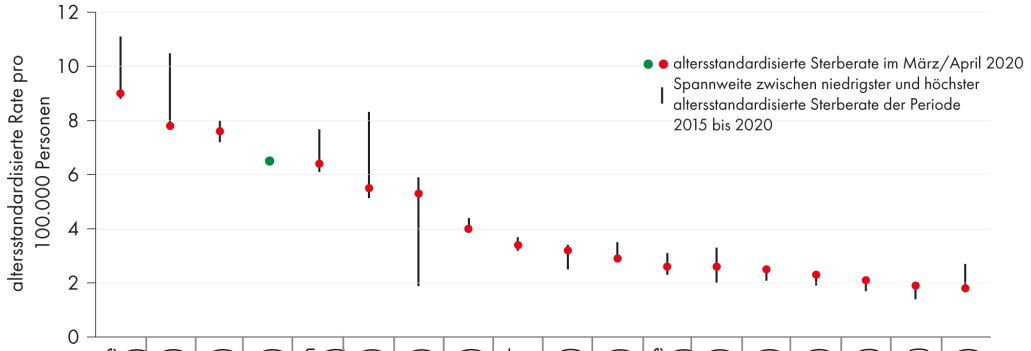
IV. Nel 2007, il numero di bambini e adolescenti con diabete di tipo 1 in Renania Settentrionale-Vestfalia era esattamente uguale a quello dei bambini e adolescenti con diabete in Germania dal 2003 al 2006.

Quale o quali affermazioni si possono dedurre dalla tabella precedente?

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) È possibile dedurre solo le affermazioni I e II.
(C) È possibile dedurre solo le affermazioni I, II e III.
(D) È possibile dedurre solo le affermazioni II e III.
(E) È possibile dedurre soltanto le affermazioni II, III e IV.

17. Nell'illustrazione seguente, i tassi di mortalità standardizzati per età nei mesi di marzo e aprile sono mostrati con le rispettive cause di morte. In questo caso, il tasso di mortalità del 2020 viene confrontato tramite un punto con il tasso di mortalità degli anni precedenti, rappresentato da una linea.

Altersstandardisierte Sterberaten (ASR) in den Monaten März/April der Periode 2015 bis 2020* nach ausgewählten Todesursachen bzw. Todesursachengruppen



	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	Herzinfarkt (I21-I22)	Lungenkrebs (C33-C34)	COVID-19 (U07)	Chronische Atemwegserkrankungen exkl. Asthma (J40-J44, J47)	Diabetes (E10-E14)	Demenz (F01,F03)	Dickdarmkrebs (C18-C21)	Krebs der Bauchspeichel-drüse (C25)	Nierenkrankheit (N00-N29)	Brustkrebs (C50)	Leberkrankheit und -zirrhose (K70, K73-K74)	Pneumonie (J12-J18)	Prostatakrebs (C61)	Alzheimer Krankheit (G30)	Morbus Parkinson (G20)	Unfälle durch Sturz (W00-W19)	Selbsttötung (X60-X84, Y870)
Höchste ASR	11,1	10,5	8,0	6,5	7,7	8,3	5,9	4,4	3,7	3,4	3,5	3,1	3,3	2,6	2,4	2,2	1,9	2,7
Niedrigste ASR	8,8	7,8	7,2	6,5	6,1	5,1	1,9	3,9	3,2	2,5	2,9	2,3	2,0	2,1	1,9	1,7	1,4	1,8
ASR 2020	9,0	7,8	7,6	6,5	6,4	5,5	5,3	4,0	3,4	3,2	2,9	2,6	2,6	2,5	2,3	2,1	1,9	1,8

Q: STATISTIK AUSTRIA, Todesursachenstatistik Stand 23.6.2020. – *) vorläufige Daten. – Vergleichsperioden März/April der Jahre 2015 bis 2019. – Ausgewählte häufige Todesursachengruppen, Gruppierung gemäß EUROSTAT-Liste, vereinfachter ICD-Text. – Eine nähere Beschreibung der medizinischen Angaben auf dem Totenschein und ihrer Kodierung finden Sie in den Informationen zur Methodik. – Lesebeispiel: Die altersstandardisierte Sterberate von Diabetes im März/April 2020 lag am unteren Rand der Spannweite zwischen dem niedrigsten und höchsten beobachteten Wert von März/April der vorangegangenen fünf Jahre. Erstellt am 08.07.2020.

Quale delle seguenti affermazioni può essere ricavata dall'illustrazione?

(A) Poiché i pazienti più giovani muoiono meno frequentemente di demenza, le deviazioni dei valori massimi sono molto inferiori al tasso di mortalità standardizzato per età.

(B) Poiché non esisteva il COVID-19 prima del 2020, non sono disponibili valori comparativi.

(C) Nel 2020, le malattie cerebrovascolari hanno registrato tassi di mortalità standardizzati per età più elevati rispetto alle altre cause elencate.

(D) Il suicidio non è tanto mortale quanto la malattia cerebrovascolare.

(E) Nel 2020, l'infarto è stato una causa di morte più frequente rispetto agli anni precedenti.

18. Questa tabella mostra la percentuale di resistenza di due batteri, E. coli e K. pneumoniae, a diversi gruppi di antibiotici in Svizzera nel 2017. I due batteri sono stati isolati da campioni di sangue e di liquido cerebrospinale (CSF) (N = numero di campioni isolati) e successivamente testati per la resistenza a diversi antibiotici.

Nelle righe (R) viene indicata una resistenza completa a questo batterio indipendentemente dal livello di dose, mentre nelle righe (I+R) viene indicata una resistenza completa o un effetto solo a una dose elevata dell'antibiotico.

Table 5.35 Percentages of resistance for *E. coli* and *K. pneumoniae* among blood and CSF isolates in Switzerland, 2017

	E. coli		*K. pneumoniae*	
Antibiotic (group)	**N**	**Resistance (%)**	**N**	**Resistance (%)**
Amoxicillin/ampicillin (R)[a]	5394	49	NA	NA
Amoxicillin-clavulanic acid (R)	5390	23	960	13
Piperacillin-tazobactam (R)	5372	4	959	5
Cefotaxime/ceftriaxone (R)[b]	5375	9	960	6
Cefotaxime/ceftriaxone (I+R)[b]	5375	9	960	7
Ceftazidime (R)	5372	7	947	6
Ertapenem (R)	4060	0	714	0
Imipenem/meropenem (R)[c]	5378	0	959	0
Imipenem/meropenem (I+R)[c]	5378	0	959	0
Gentamicin/tobramycin (R)[d]	5388	8	961	5
Amikacin (R)	3968	2	730	1
Ciprofloxacin/levofloxacin/ofloxacin (R)[e]	5397	17	961	8
Ciprofloxacin/levofloxacin/ofloxacin (I+R)[e]	5397	19	961	11
Multidrug resistance (R)[f]	5385	3	959	3

NA: not applicable.
[a] Amoxicillin and ampicillin are indicators for the group of aminopenicillins.
[b] Cefotaxime and ceftriaxone are indicators for the group of third-generation cephalosporins.
[c] Imipenem and meropenem are indicators for the group of carbapenems.
[d] Gentamicin and tobramycin are indicators for the group of aminoglycosides.
[e] Ciprofloxacin, levofloxacin and ofloxacin are indicators for the group of fluoroquinolones.
[f] Multidrug resistance is defined as resistance to ciprofloxacin/levofloxacin/ofloxacin, cefotaxime/ceftriaxone/ceftazidime and gentamicin/tobramycin. Isolates with missing data on one or more of the groups were excluded.

I. Il batterio E. coli è stato isolato da sangue e liquido cerebrospinale almeno 3’968 volte in Svizzera nel 2017.

II. Oltre a Ertapenem, i carbapenemi sono gli unici antibiotici che presentano una percentuale di resistenza dello 0% contro tutti i batteri conosciuti.

III. Nel 2017, in Svizzera si è registrato un numero di casi completi di resistenza di E. coli ai fluorochinoloni pari a circa 5,6 volte quello dei casi completi di resistenza di K. pneumoniae ai fluorochinoloni.

IV. Circa 48 delle K. pneumoniae isolate in Svizzera nel 2017 erano completamente resistenti agli antibiotici aminoglicosidi.

Quale o quali affermazioni sono vere secondo la tabella?

(A) Tutte le affermazioni sono vere.
(B) Solo le affermazioni I, II e III sono vere.
(C) Solo le affermazioni I, III e IV sono vere.
(D) Solo le affermazioni I e IV sono vere.
(E) Solo le affermazioni III e IV sono vere.

Fonti

1. https://www.krebsliga.ch/ueber-krebs/zahlen-fakten/-dl-/fileadmin/downloads/sheets/zahlen-krebs-in-der-schweiz.pdf
2. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/kosten-finanzierung.assetdetail.22324799.html
3. https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/case/d/demography?geoView=table&demoView=graph
4. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Krankheitskosten/_inhalt.html
5. https://zahlen-fakten.suchtschweiz.ch/de/alkohol/kennzahlen.html
6. https://www.statistik.at/web_de/services/publikationen/4/index.html?includePage=detailedView&sectionName=Gesundheit&pubId=543
7. https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/gesundheitszustand/index.html
8. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszustand/krankheiten/herz-kreislauf-erkrankungen.assetdetail.19444365.html
9. https://statistik.tg.ch/themen-und-daten/soziales-gesundheit-bildung/gesundheit/lebenserwartung.html/6948
10. https://en.wikipedia.org/wiki/File:HBV_serum_markers.jpg
11. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesInDtld/gesundheit_in_deutschland_2015.html;jsessionid=FCAE447F7FF36D6CD8A895783C60325C.internet082?nn=2379316
12. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/stationaere_aufenthalte/index.html
13. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.21244126.html
14. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesInDtld/gesundheit_in_deutschland_2015.html;jsessionid=FCAE447F7FF36D6CD8A895783C60325C.internet082?nn=2379316
15. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/krebserkrankungen/index.html
16. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GesInDtld/gesundheit_in_deutschland_2015.html;jsessionid=FCAE447F7FF36D6CD8A895783C60325C.internet082?nn=2379316
17. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/todesursachen/index.html
18. https://www.euro.who.int/de/publications/abstracts/central-asian-and-eastern-european-surveillance-of-antimicrobial-resistance-annual-report-2018-2018